Andalan Artha Primanusa

## LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|---|---|
| **NAMA DOKUMEN** | **PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK)** |
| **NOMOR DOKUMEN** | **SHE-SOP-032** |
| **DIVISI/DEPT.** | **SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)** |
| **TANGGAL EFEKTIF** | **01 AGUSTUS 2025** |

**Catatan Perubahan**

| No. Revisi | Hal | Uraian Singkat Perubahan | Diperiksa Tanggal | Disetujui Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**KOLOM PENGESAHAN**

| Dibuat oleh | Disetujui oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|
| | | |
| Anton Sujarwo | Roy Hansen C. Saragih | Gahari Christine |
| SHE Manager | General Manager | Direktur |

**DAFTAR ISI**

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

## 1. TUJUAN

1.1. Tersedianya pedoman diagnosis dan tata laksana Penyakit Akibat Kerja (PAK) di di seluruh lingkungan perusahaan.

1.2. Untuk menetapkan suatu sistem Pelaporan dan Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang seragam di seluruh lingkungan perusahaan.

1.3. Untuk memastikan setiap Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang terjadi diselidiki secara benar dan tindakan perbaikan yang sesuai dilaksanakan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi panduan dan petunjuk tentang pemantauan termasuk pelaporan dan penyelidikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang mungkin terjadi di seluruh area kerja PT.AAP.

## 3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.

3.2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

3.3. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3.4. PP No. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

3.5. PerPres No. 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

3.6. KepMenaker No. KEP.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

3.7. PerMenakerTrans No. PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.

3.8. PerMenaker No. PER.25/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Diagnosis dan penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan penyakit Akibat Kerja.

3.9. KepDirJenBinWasNaker No. KEP. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

3.10. KepMenKes No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu.

3.11. PerMenKes No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja.

3.12. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.13. Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah

DOKUMEN TERKENDALI



© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Teknik Pertambangan yang Baik.

3.14. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.15. ISO 45001: 2018 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

## 4. DEFINISI

4.1. **Penyakit Akibat Kerja** adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungankerja.

4.2. **Kesehatan Kerja** adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

4.3. **Dokter** adalah dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.

4.4. **Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja** adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha atau kepala instansi/lembaga dan disahkan oleh Direktur setelah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

4.5. **HRGA**adalah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas hygiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

4.6. **Tempat Kerja** adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.7. **Diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK)** adalah penentuan jenis Penyakit Akibat Kerja dengan cara meneliti (memeriksa) secara sistematis dan terarah melalui 7 (tujuh) langkah diagnosis okupasi.

## 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

5.1.2. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

5.2. Department Head / Section Head

5.2.1. Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan SOP ini pada karyawan.

5.2.2. Melaksanakan ketentuan dalam prosedur ini.

5.2.3. Memastikan Prosedur ini berjalan sebagaimana mestinya.

5.3. SHE Department

5.3.1. Melakukan evaluasi / tindak lanjut pada priode tertentu untuk memastikan bahwa prosedur ini diterapkan.

5.3.2. Melakukan review terhadap Prosedur ini secara berkala.

## 6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Keluhan Dugaan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

6.1.1. Setiap karyawan yang diduga mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) segera melaporkan kepada atasan yang bersangkutan.

6.1.2. Atasan yang bersangkutan meneruskan informasi tersebut kepada HRGA dan SHE Site atau HRGA dan SHE Corporate untuk karyawan yang berada di area lokasi Head Office Jakarta.

6.2. Penilaian Medis

6.2.1. SHE Site dan HRGA Site atau SHE Corporate dan HRGA untuk karyawan yang berada di area lokasi Head Office Jakarta, TC Balikpapan, dan Depo Somber segera melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan PAK yang terjadi.

6.2.2. Karyawan yang diduga mengalami PAK dilakukan anamnesis dan pemeriksaan oleh HRGA Site atau HRGA untuk karyawan yang berada di area lokasi Head Office Jakarta, untuk dianalisis dan evaluasi awal dari data rekam medis dan medical check up.

6.2.3. HRGA Site membuat laporan dengan menggunakan form Laporan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja ke Dept. Head SHE Site. Untuk area Head Office Jakarta, HRGA membuat laporan ke General Manager.

6.3. Pelaporan Dugaan Penyakit Akibat Kerja

6.3.1. Apabila ada dugaan PAK, HRGA Sitedan SHE Site menginformasikan laporan untuk koordinasi dan konsultasi ke SHE Corporate dan HRGAdengan melampirkan analisa dugaan PAK dalam Form Laporan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja.

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

6.3.2. Laporan Hasil evaluasi awal dugaan PAK dilengkapi dengan semua data - data pendukung dari Site yang sudah dikumpulkan.

6.3.3. SHE Corporate akan membuat rekomendasi tindakan investigasi terkait kasus dugaan PAK yang terjadi kepada HRGA Sitedan HRGAsesuai klasifikasi PAK.

6.4. Diagnosa Klinis dan Okupasi

6.4.1. Diagnosa Kiinis

6.4.1.1. HRGA Site dibantu oleh HRGA akan membuat diagnosis klinis. Bila diagnosis klinis belum dapat ditegakkan, maka HRGAdapat merujuk karyawan ke Dokter Spesialis terkait atau merujuk ke Rumah Sakit.

6.4.2. Diagnosis Okupasi

6.4.2.1. Setelah diagnosis klinis ditegakkan, dilanjutkan dengan diagnosis okupasi oleh Dokter Site, Dokter Perusahaan, dan Dokter Spesialis terkait.

6.4.2.2. Dalam mendiagnosis okupasi PAK terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan:

6.4.2.2.1. Hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit.

6.4.2.2.2. Frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada pada masyarakat.

6.4.2.2.3. Penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

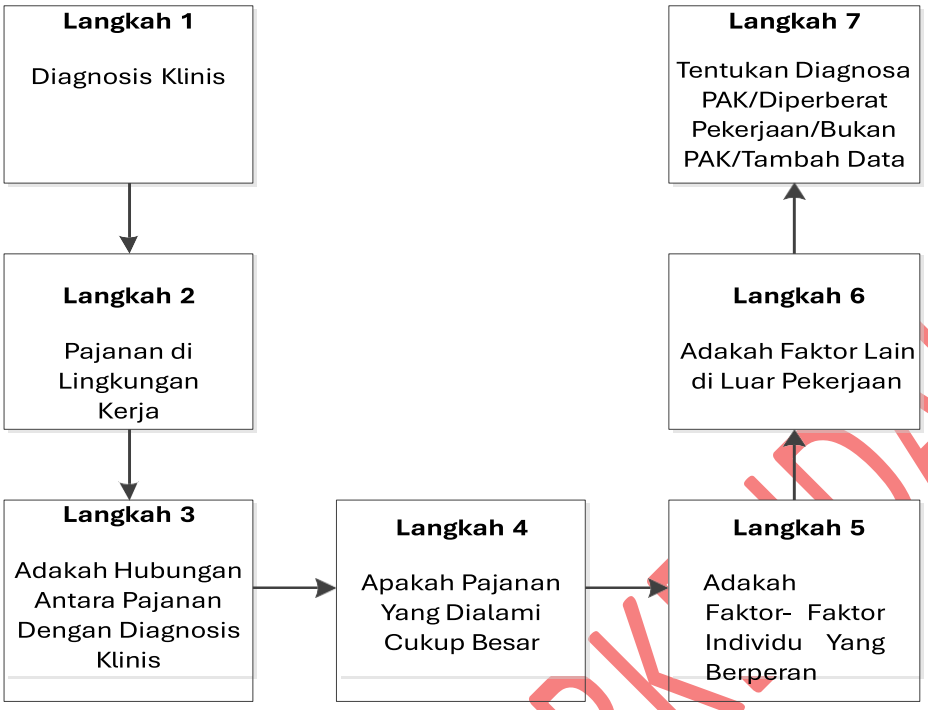
6.4.2.3. Penegakan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja

Diagnosis PAK ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya.
Diagnosis PAK dilakukan dengan pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan interpretasi secara tepat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) langkah diagnosis penyakit akibat kerja dilakukan sebagai berikut:

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*




***Gambar 1. Tujuh langkah Diagnosis Penyakit Akibat Kerja***

**Keterangan :**

**Langkah 1. Menegakkan diagnosis klinis**

Diagnosis klinis harus ditegakkan terlebih dahulu dengan melakukan

1. Anamnesa
2. Pemeriksaan fisik
3. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan khusus.

**Langkah 2. Menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja**

Beberapa pajanan dapat menyebabkan satu penyakit, sehingga dokter harus mendapatkan informasi semua pajanan yang dialami dan pernah dialami oleh pekerja. Untuk memperoleh informasi tersebut, dilakukan anamnesis pekerjaan yang lengkap, mencakup:

1. Deskripsi semua pekerjaan secara kronologis dan pajanan yang dialami (pekerjaan terdahulu sampai saat ini).
2. Periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan.
3. Produk yang dihasilkan.
4. Bahan yang digunakan.
5. Cara bekerja.

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

6. Proses kerja.
7. Riwayat kecelakaan kerja (tumpahan bahan kimia).
8. Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan.

Informasi tersebut semakin bernilai, bila ditunjang dengan data yang objektif, seperti MSDS (*Material Safety Data Sheet)* dari bahan yang digunakan dan catatan perusahaan mengenai informasi tersebut diatas.

**Langkah 3. Menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis**

Pajanan yang teridentifikasi berdasarkan *evidence based* dihubungkan dengan penyakit yang dialami. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu. Penyakit lebih sering timbul apabila berada di tempat kerja dan berkurang saat libur atau cuti. Hasil pemeriksaan pra-kerja dan berkala dapat digunakan sebagai salah satu data untuk menentukan penyakit berhubungan dengan pekerjaannya.

**Langkah 4. Menentukan besarnya pajanan**

Penilaian untuk menentukan kecukupan pajanan tersebut untuk menimbulkan gejala penyakit dapat dilakukan secara :

1. **Kualitatif:**
   a. Pengamatan cara, proses dan lingkungan kerja dengan memperhitungkan lama kerja dan masa kerja.
   b. Pemakaian alat pelindung secara benar dan konsisten untuk mengurangi besar pajanan.
2. **Kuantitatif:**
   a. data pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan secara periodik.
   b. data monitoring biologis.

**Langkah 5. Menentukan faktor individu yang berperan**

Faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit antara lain:

1. Jenis kelamin
2. Usia
3. Kebiasaan
4. Riwayat penyakit keluarga (genetik)
5. Riwayat atopi
6. Penyakit penyerta.

**Langkah 6. Menentukan pajanan di luar tempat kerja**

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

Penyakit yang timbul mungkin disebabkan oleh pajanan yang sama di luar tempat kerja sehingga perlu informasi tentang kegiatan yang dilakukan di luar tempat kerja seperti hobi, pekerjaan rumah dan pekerjaan sampingan.

**Langkah 7. Menentukan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja**

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, dibuat kesimpulan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja.

- Diagnosis okupasi ditegakkan melalui 7 (tujuh) langkah diagnosis okupasi. Bila diagnosis okupasi belum dapat ditegakkan oleh Perusahaan, maka HRGA Sitedan HRGAdapat merujuknya ke Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi setelah mendapatkan data-data penunjang di lingkungan kerja.
- Jika dugaan PAK terbukti maka HRGA akan menetapkan kasus tersebut dan SHE terkait yang membuat RTP kemudian mendistribusikannya ke pihak terkait sesuai PIC yang tertera di PICA.

6.5. Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja

Penatalaksanaan kasus yaitu penatalaksaan medis dan penatalaksanaan okupasi. Dalam melakukan penatalaksaan medis, apabila terdapat keraguan, maka dokter merujuk ke dokter spesialis terkait sedangkan, apabila terdapat keraguan dalam penatalaksanaan okupasi, dokter berkonsultasi ke spesialis kedokteran okupasi. Tata laksana penyakit akibat kerja akan dilakukan oleh HRGA Site atau dokter corporate secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu tata laksana medis dan tata laksana okupasi.

6.5.1. Tata Laksana Medis

Tata laksana medis dilakukan setelah diagnosis klinis pada langkah pertama diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan. Tata laksana medis berupa rawat jalan dan/atau konseling, psikoterapi, dan nutrisi. Rujukan klinis dilakukan apabila diagnosis klinis belum dapat ditegakkan karena :

- Timbul keraguan dari dokter yang melakukan pemeriksaan.
- Sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tidak memadai.

6.5.2. Tata Laksana Okupasi

Tata laksana okupasi dilakukan oleh dokter spesialis okupasi dan diberikan setelah diagnosis PAK ditegakkan. Sasaran tata laksana okupasi adalah individu pekerja dan komunitas pekerja. Tata laksana okupasi pada individu pekerja terdiri dari penetapan kelaikan kerja, program kembali bekerja dan penentuan kecacatan.

DOKUMEN TERKENDALI



© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.5.2.1. Penetapan Kelaikan Kerja

Penetapan kelaikan kerja meliputi penilaian risiko, kapasitas dan tolerasi pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang ada di tempat kerja. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pekerja tersebut dapat kembali bekerja pada pekerjaan sebelumnya, bekerja dengan keterbatasan (limitasi) ataupun restriksi tertentu atau berganti pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pekerja. Rujukan penentuan kelaikan kerja diperlukan jika:

- Status kesehatan pasien kompleks (melibatkan lebih dari 1 (satu) sistem organ atau melibatkan hanya 1 (satu) sistem organ tetapi sistem organ yang vital).
- Pajanan faktor risiko yang ada di tempat kerja kompleks dan saling berkaitan.
- Terdapat keraguan dalam menentukan besaran risiko yang ada dan risiko yang dapat diterima (acceptable risk).
- Terdapat ketidakpuasan pekerja atas penetapan kelaikan kerja.
- Penetapan kelaikan kerja diperlukan untuk penetapakan kelaikan kerja calon kepala daerah atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
- Ada permintaan dari bagian kepegawaian atau bagian keselamatan dan kesehatan kerja suatu perusahaan.
- SDM dan sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan tidak memadai.

6.5.2.2. Program Kembali Bekerja (*return to work*)

Suatu upaya terencana agar pekerja yang mengalami cedera/sakit dapat segera kembali bekerja secara produktif, aman dan berkelanjutan. Dalam upaya ini termasuk pemulihan medis, pemulihan kerja, pelatihan keterampilan, penyesuaian pekerjaan, penyediaan pekerjaan baru, penatalaksanaan biaya asuransi dan kompensasi serta partisipasi pemberi kerja.

Rujukan program kembali bekerja dilakukan jika:

- Diperlukan kunjungan ke tempat kerja pasien untuk melihat pekerjaan lain yang tersedia yang cocok dengan kondisi medis pasien.
- Status kesehatan pasien kompleks (melibatkan lebih dari 1(satu) sistem organ atau melibatkan hanya 1 (satu) sistem organ tetapi sistem organ yang vital).

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

- Pajanan faktor risiko yang ada di tempat kerja kompleks dan saling berkaitan.
- Terdapat keraguan dalam menentukan besaran risiko yang ada dan risiko yang dapat diterima (acceptable risk).
- Terdapat ketidakpuasan pekerja atas program kembali bekerja.

6.5.2.3. Penentuan Kecacatan

Penyakit akibat kerja dapat menimbulkan disabilitas akibat kecacatan anatomi maupun fungsi yang perlu dinilai persentasenya sehingga pekerja berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rujukan penentuan kecacatan diperlukan jika:

- Jenis kecacatan belum ada dalam pedoman penentuan kecacatan.
- Terdapat ketidakpuasan pekerja atas penetapan persentase kecacatan.
- Terdapat keberatan dari pihak pemberi jaminan pelayanan kesehatan atas penetapan persentase kecacatan.
- Diperlukan untuk kepentingan legal seperti kompensasi ganti rugi di luar dari yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.6. Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

6.6.1. Pencatatan

- HRGA Site dan SHE Site atau HRGAdan SHE Corporate untuk area Head Office Jakarta, TC Balikpapan, dan Depo Somber melakukan pencatatan kasus diduga penyakit akibat kerja dan kasus penyakit akibat kerja yang telah terbukti di dalam rekam medis.
- Pencatatan penyakit akibat kerja dilakukan sebagai bagian dari surveilans kesehatan pekerja.

6.6.2. Pelaporan

- Penyakit akibat kerja yang ditemukan (dugaan penyakit akibat kerja yang terbukti) harus dilaporkan oleh HC terkait bersama HRGAselambat lambatnya 2 x 24 jam setelah diagnosis PAK ditegakan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan **PerMenKes No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja**.
- Pelaporan Penyakit Akibat Kerja juga dikirimkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait dengan pembiayaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan form yang dikeluarkan oleh BPJS

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

Ketenagakerjaan seperti pada **Lampiran SHE-41-01L Laporan Kasus PAK**.

## 7. ALUR PROSEDUR

| DIAGRAM ALIR | DOKUMEN PENDUKUNG | PIC | INDICATOR PROSES |
|---|---|---|---|
| Mulai | | | |
| 1 Keluhan Dugaan PAK | | - Karyawan / Pasien | 1. Informasi kejadian dilaporkan dengan jelas dan rinci |
| 2 Penilaian Medis | - Rekam medis dan MCU<br>- Form Laporan Diagnosis PAK, | - Dokter rekanan /perusahaan | 2. Pengumpulan dokumen pendukung melalui rekam medis dan MCU |
| 3 Pelaporan Dugaan PAK | | - Dokter/paramedic<br>- SHE Site | 3. Rekomendasi investigasi sesuai klasifikasi PAK dan Menganalisis kasus melalui Tim investigasi |
| 4 Diagnosa Klinis & Okupasi | - Rekam Medis dan MCU<br>- Hasil pemeriksaan lingkungan kerja, biomarker, dll | - Dokter rekanan / Perusahaan<br>- SHE Site | 4. Hasil rekam medis dokter spesialis faskes rujukan untuk membuktikan PAK atau bukan. |
| PAK ? (Ya / Tidak) | | - Dokter rekanan<br>- Dokter Perusahaan<br>- SHE & HRGA Site | |
| 5 Penatalaksanaan Kasus PAK | | | 5. Program Penatalaksanaan PAK |
| 6 Pencatatan dan Pelaporan PAK | - Laporan Kasus PAK<br>- Rekam Medis | - Dokter perusahaan/ rekanan<br>- HRGA | 6. Pencatatan dan pelaporan kasus karyawan yang terkena PAK |
| Selesai | | | |

DOKUMEN TERKENDALI



© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

## 8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

## 9. LAMPIRAN

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Jenis Penyakit Akibat Kerja**

I. Penyakit Yang Disebabkan Pajanan Faktor Yang Timbul Dari Aktivitas Pekerjaan Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis I ini sebagai berikut:

a. Penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, meliputi:

1. Penyakit yang disebabkan oleh berillium dan persenyawaannya;
2. Penyakit yang disebabkan oleh cadmium atau persenyawaannya;
3. Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya;
4. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya;
5. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya;
6. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya;
7. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya;
8. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya;
9. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya;
10. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida;
11. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatic;
12. Penyakit yang disebabkan oleh benzene atau homolognya;
13. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzene atau homolognya;
14. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya;
15. Penyakit yang disebabkan oleh alcohol, glikol, atau keton;
16. Penyakit yang disebabkan oleh gas penyebab asfiksia seperti karbon monoksida, hydrogen sulfida, hidrogen sianida atau derivatnya;
17. Penyakit yang disebabkan oleh acrylonitrile;
18. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogen oksida;
19. Penyakit yang disebabkan oleh vanadium atau persenyawaannya;
20. Penyakit yang disebabkan oleh antimon atau persenyawaannya;
21. Penyakit yang disebabkan oleh hexane;
22. Penyakit yang disebabkan oleh asam mineral;

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

23. Penyakit yang disebabkan oleh bahan obat;
24. Penyakit yang disebabkan oleh nikel atau persenyawaannya;
25. Penyakit yang disebabkan oleh thalium atau persenyawaannya;
26. Penyakit yang disebabkan oleh osmium atau persenyawaannya;
27. Penyakit yang disebabkan oleh selenium atau persenyawaannya;
28. Penyakit yang disebabkan oleh tembaga atau persenyawaannya;
29. Penyakit yang disebabkan oleh platinum atau persenyawaannya;
30. Penyakit yang disebabkan oleh timah atau persenyawaannya;
31. Penyakit yang disebabkan oleh zinc atau persenyawaannya;
32. Penyakit yang disebabkan oleh phosgene;
33. Penyakit yang disebabkan oleh zat iritan kornea seperti benzoquinone;
34. Penyakit yang disebabkan oleh isosianat;
35. Penyakit yang disebabkan oleh pestisida;
36. Penyakit yang disebabkan oleh sulfur oksida;
37. Penyakit yang disebabkan oleh pelarut organik;
38. Penyakit yang disebabkan oleh lateks atau produk yang mengandung lateks; dan
39. Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan bahan kimia dan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;

b. Penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, meliputi:
   1. Kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan;
   2. Penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan pada otot, tendon, tulang, sendi, pembuluh darah tepi atau saraf tepi;
   3. Penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi;
   4. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi ion;
   5. Penyakit yang disebabkan oleh radiasioptik, meliputi ultraviolet, radiasi elektromagnetik (*visible light*), infra merah, termasuk laser;
   6. Penyakit yang disebabkan oleh pajanan temperatur ekstrim; dan
   7. Penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor fisika yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;

c. Penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit, meliputi:
   1. *Brucellosis*;
   2. Virus hepatitis;
   3. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
   4. Tetanus;
   5. Tuberkulosis;

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

6. Sindrom toksik atau inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur;
7. *Anthrax*;
8. Leptospira; dan
9. Penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor biologi yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.

II. Penyakit Berdasarkan Sistem Target Organ

Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis II ini sebagai berikut:

a. Penyakit saluran pernafasan, meliputi:
   1. Pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut, meliputi silikosis, antrakosilikosis, dan asbestos;
   2. Siliko tuberkulosis;
   3. Pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral non- fibrogenic;
   4. Siderosis;
   5. Penyakit bronkhopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras;
   6. Penyakit bronkhopulmoner yang disebabkan oleh debu kapas, meliputi bissinosis, vlas, henep, sisal, dan ampas tebu atau bagassosis;
   7. Asma yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi atau zat iritan yang dikenal yang ada dalam proses pekerjaan;
   8. Alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik atau aerosol yang terkontaminasi dengan mikroba, yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
   9. Penyakit paru obstruktif kronik yang disebabkan akibat menghirup debu batu bara, debu dari tambang batu, debu kayu, debu dari gandum dan pekerjaan perkebunan, debu dari kandang hewan, debu tekstil, dan debu kertas yang muncul akibat aktivitas pekerjaan;
   10. Penyakit paru yang disebabkan oleh aluminium;
   11. Kelainan saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh sensitisasi atau iritasi zat yang ada dalam proses pekerjaan; dan
   12. Penyakit saluran pernafasan lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;

b. Penyakit kulit, meliputi:
   1. Dermatosis kontak alergika dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul dari aktivitas pekerjaan yang tidak termasuk dalam penyebab lain;
   2. Dermatosis kontak iritan yang disebabkan oleh zat iritan yang timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain; dan

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

3. Vitiligo yang disebabkan oleh zat penyebab yang diketahui timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak temasuk dalam penyebab lain;

c. Gangguan otot dan kerangka, meliputi:
   1. *Radial styloid tenosynovitis* karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan;
   2. Tenosynovitis kronis pada tangan dan pergelangan tangan karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan;
   3. Olecranon bursitis karena tekanan yang berkepanjangan pada daerah siku;
   4. Prepatellar bursitis karena posisi berlutut yang berkepanjangan;
   5. Epicondylitis karena pekerjaan repetitif yang mengerahkan tenaga;
   6. Meniscus lesions karena periode kerja yang panjang dalam posisi berlutut atau jongkok;
   7. Carpal tunnel syndrome karena periode berkepanjangan dengan gerak repetitif yang mengerahkan tenaga, pekerjaan yang melibatkan getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan, atau 3 (tiga) kombinasi diatas; dan
   8. Penyakit otot dan kerangka lain yang tidak disebutkan diatas, dimana ada hubungan langsung antara paparan faktor yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dan penyakit

otot dan kerangka yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;

d. Gangguan mental dan perilaku, meliputi:
   1. Gangguan stres pasca trauma; dan
   2. Gangguan mental dan perilaku lain yang tidak disebutkan diatas, dimana ada hubungan langsung antara paparan terhadap faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan gangguan mental dan perilaku yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.

III. Penyakit Kanker Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis III ini, yaitu kanker yang disebabkan oleh zat berikut:

1. Asbestos;
2. Benzidine dan garamnya;
3. Bis-chloromethyl ether;
4. Persenyawaan chromium VI;
5. Coal tars, coal tar pitches or soots;
6. Beta-naphthylamine;
7. Vinyl chloride;
8. Benzene;
9. Toxic nitro dan amino benzene derivatif atau homolognya;
10. Radiasi mengion;

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

11. Ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaannya, produk atau residu dari zat ini;
12. Emisi oven arang;
13. Persenyawaan nikel;
14. Debu kayu;
15. Arsen dan persenyawaannya;
16. Beryllium dan persenyawaannya;
17. Cadmium dan persenyawaannya;
18. Erionite;
19. Ethylene oxide;
20. Virus Hepatitis B dan virus Hepatitis C;
21. Kanker yang disebabkan zat lain yang tidak disebutkan diatas, dimana ada hubungan langsung antara paparan terhadap zat penyebab yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan kanker yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.

IV. Penyakit Spesifik Lainnya

Penyakit spesifik lainnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, dimana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contoh penyakit spesifik lainnya, yaitu *nystagmus* pada penambang.

DOKUMEN TERKENDALI



*© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*